

COVID19 des mots, des chiffres et un maillon manquant

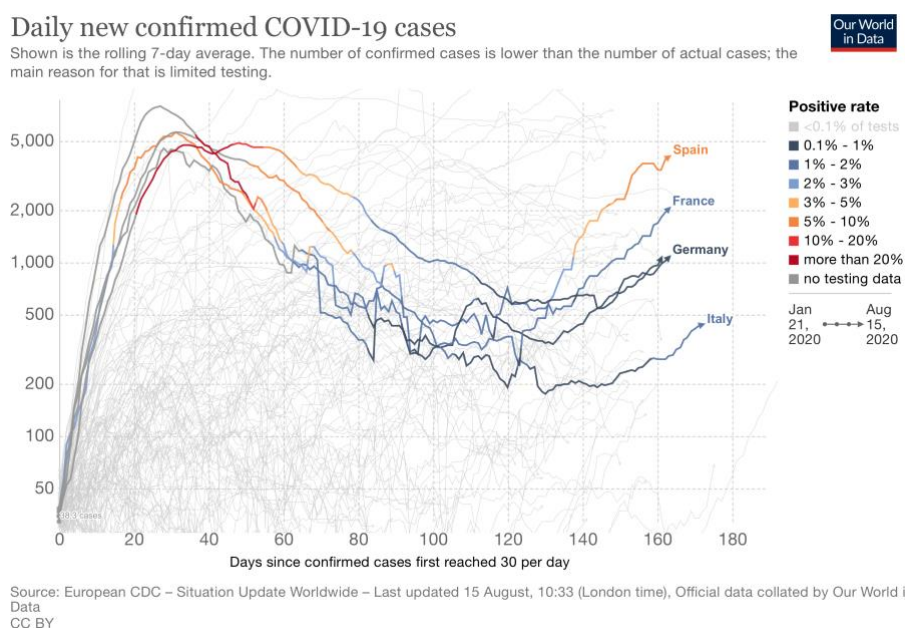
Cas et décès

L'évolution d'une épidémie est généralement décrite à partir de données recueillies sur le nombre de cas (ce qui regroupe généralement les malades et des asymptomatiques *testés*), et par le nombre de personnes hospitalisées, en réanimation, et le nombre de décès. Ces statistiques permettent de calculer la létalité liée à l'épidémie, c'est-à-dire le taux de mortalité des personnes « atteintes », ce qui, bien entendu nécessite de bien comprendre ce qu'on mesure (ou pas), qu'il s'agisse des cas, ou des décès.

On a vu, selon les pays, que les deux indicateurs de cas et de décès, pouvaient ne pas avoir le même contour, c'est-à-dire la même définition ou représentativité. Ainsi, pendant un certain temps en France, on ne suivait pas les décès dans les maisons de retraite, et on testait peu. Ce qui rendait difficile la comparaison des fameux « CFR » c'est-à-dire le rapport de la mortalité au nombre de cas.

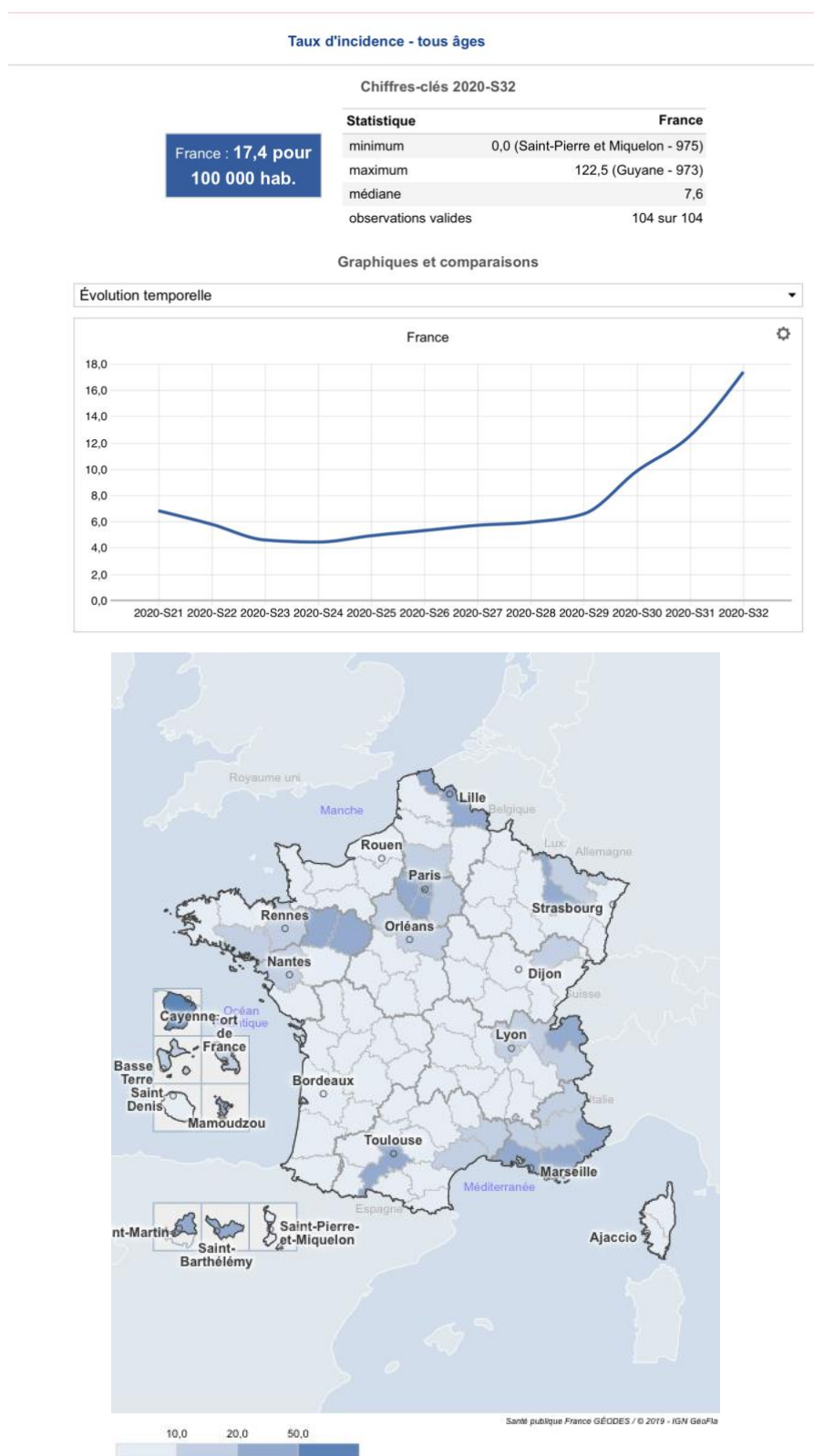
Le fait que l'on teste peu au début de l'épidémie a conduit à une létalité élevée globale en France, mais d'autres facteurs sont aussi cependant possiblement en cause comme la politique sanitaire mise en œuvre (« restez chez vous tant que vous n'avez pas de gêne respiratoire ») et le type de soin administré (cf le débat « tordu » sur les protocoles de soin et les décisions hâtives du gouvernement).

Toujours est-il que, après le pic épidémique du printemps, et le déconfinement, on a assisté en Europe à une augmentation du nombre de cas avérés (essentiellement testés), avec une positivité variable et plutôt croissante.



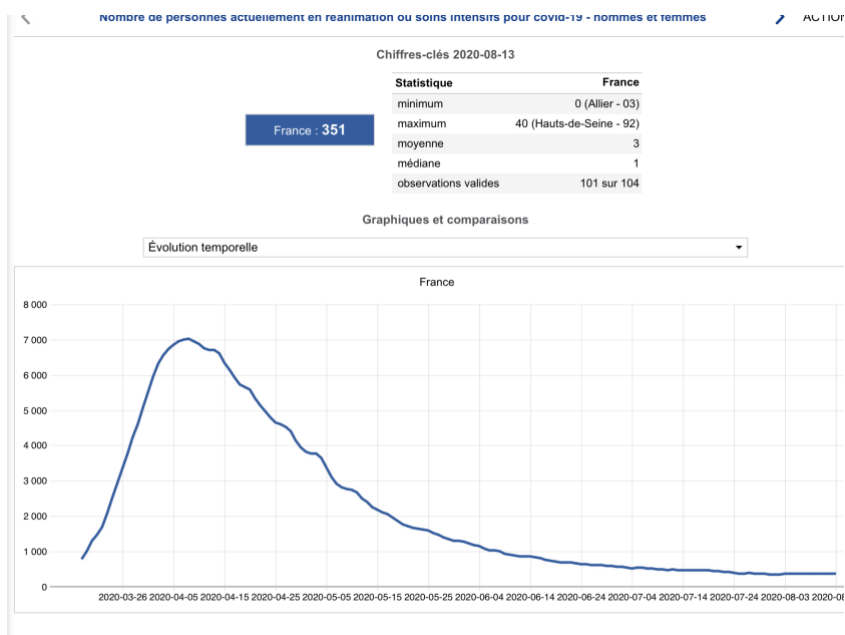
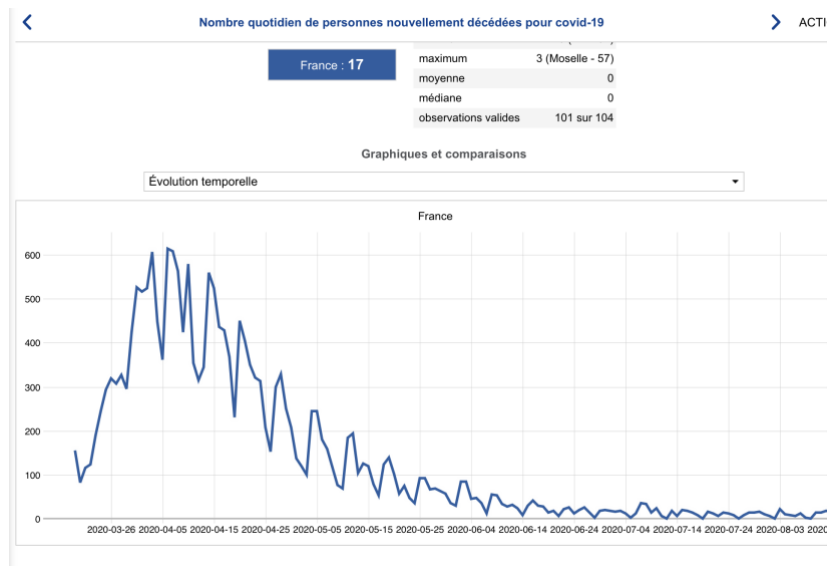
Sur la base de ces données, qu'on présente selon les découpages administratifs, on calcule le « taux d'incidence », c'est-à-dire la part estimée de la population qui est « infectée ».

Ce qui donne, en données hebdomadaires, des courbes effectivement croissantes en France (semaine 32), avec une disparité territoriale réelle.



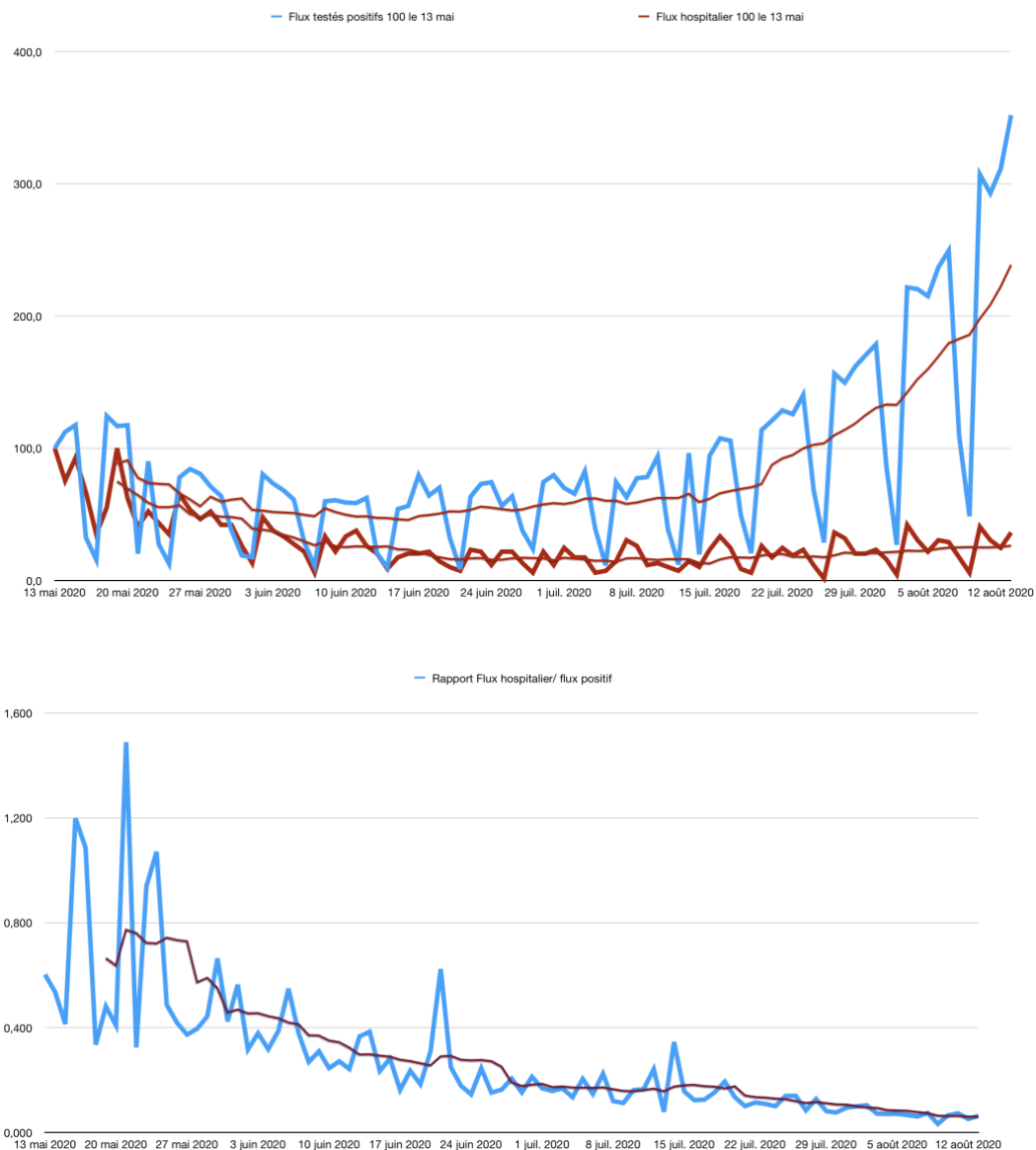
Entre dangerosité avancée et et non dangerosité apparente statistiquement...

Or, parallèlement, on ne note aucun mouvement inquiétant, statistiquement, du côté des décès comme des hospitalisations.



Pour résumer, on nous explique d'un côté que le virus continue de se propager et de contaminer la population (auprès de laquelle on réédite les conseils voire les injonctions ou obligations de distanciation sociale), mais de l'autre on constate que sa « dangerosité » n'est plus de même nature « statistiquement ».

On peut le vérifier en visualisant le flux quotidien d'hospitalisations pour « Covid19 » et celui des tests positifs, et naturellement, le rapport entre les deux. Pour simplifier la lecture on a mis en base 100 au 13 mai 2020 les deux flux étudiés. Au surplus nous avons tracé des moyennes mobiles sur une semaine en surimpression des courbes.



A première vue donc, il y aurait donc une décroissance de la dangerosité apparente de la contamination.

Statistiques de quoi ?

Ce qui conduit à s'interroger sur le virus, sur les statistiques, et sur les mécanismes épidémiques en cause, d'autant que les populations testées (et positives) n'ont rien d'un échantillon représentatif de la population française (ou locale).

En l'absence d'étude statistique sérologique de grande ampleur en France, on ne sait répondre la question simple : combien reste-t-il de personnes n'ayant pas contracté le Covid19. Et on n'est peu éclairé par des études sur le degré réel de dangerosité actuelle du virus.

Tout cela nous ramène au processus d'observation.

En France par exemple on pratique un peu plus de 1,5 test pour 1000 habitants par jour ouvrable (?) avec des disparités considérables d'un département à l'autre (le 11 Août, 89026 personnes testées, Minimum 0, maximum Paris : 5378, médiane 456, le taux quotidien de tests pour 100 000 habitants varie ainsi selon les départements de 0 à plus de 320 à la mi-août (médiane : autour de 117). Autant dire que la représentativité des tests est illusoire, et qu'il n'y a pas de méthode statistique de test. Par ailleurs, au rythme actuel il faudrait moins d'un an pour tester la totalité de la population des Bouches du Rhône.. Et sans doute plusieurs années (décennies ?) ailleurs.

Que signifient alors les résultats ? S'ils n'ont pas ou peu de représentativité qu'en faire ?

On attendrait des spécialistes une analyse, une ébauche d'analyse, des hypothèses, au lieu de quoi, rien ou presque.

Les jeunes et les vieux

Reste l'argument souvent évoqué de l'âge des cas positifs.

Difficile de se faire une idée précise dans la mesure où, en pleine croissance épidémique, on testait essentiellement des cas graves avérés. Cependant, on peut observer de manière générale, une contamination plus forte des personnes jeunes (autour de 3 à 4 % des testés) avec une pointe pour les 20-30 ans autour de 4,5 %. A-t-on des hypothèses sur ces différences ? Celles-ci peuvent expliquer en partie la faible morbidité et la faible létalité. Pour autant, à quoi peut-on attribuer la faible positivité des plus âgés, et singulièrement des personnes de plus de 80 ans ?

Il est en effet frappant que le taux de personnes testées positives de grand âge est faible, mais, s'il semble augmenter légèrement, le niveau d'hospitalisation ne semble pas non plus suivre l'évolution des cas positifs.



Personne, à notre connaissance n'explique ces phénomènes en dehors de la mise en avant du nombre moindre de contacts des plus vieux qui, faute d'étude n'est qu' hypothétique.

Il reste que l'examen des chiffres de Geodes interpèle sur le fond (que se passe-t-il ?) mais aussi sur la forme.

En effet, les tranches d'âge des différentes données ne sont pas identiques...

Par ailleurs certaines notions ont un sens difficile à interpréter. Ainsi, la notion de taux d'incidence en matière de tests « *correspond au nombre de nouvelles personnes testées positives pour un tests de SARS-COV2, rapporté à la population pour 100 000 habitants, par jour* ». Il s'agit donc d'un flux (avec ou non remise) rapporté à un stock de population, après remontée et affectation des résultats au département de résidence. Ce qui en période de vacances complique l'analyse et la compilation rigoureuse des données. L'interprétation de ce « taux » est difficile. Son augmentation indique sans contestation une augmentation du nombre de cas positif et de celui des tests pratiqués que le taux de positivité relevé permet de départager. Mais ce taux n'est aucunement une mesure d'un état sanitaire (rapport de deux stocks) ni même de son estimation, sans analyse de la population testée et des « motifs » de test. C'est encore moins un indicateur de « dangerosité épidémique.

Et du coup, nos questions, restent à ce stade de la communication de données et des études publiées à notre connaissance, sans réponses.

D'où ce contraste « troublant » entre les discours alarmistes et les données factuelles de santé publique. Or la communication c'est aussi (du moins ce devrait l'être) l'apport d'explications crédibles. Espérons qu'elles arrivent.

P.S. 17 Août 2020